



Tashkheesa Diagnostic Opinion Report

تقرير رأي تشخيصي من تشخيصية

CASE ID: TK-2026-09-0111 SPECIALTY: Cardiology SERVICE TIER: Standard · 48h SUBMITTED: 17 Sep 2026 · 21:14 ISSUED: 19 Sep 2026 · 14:02

نموذج توضيحي — مش تقرير حقيقي ومش بيانات مريض حقيقي

SAMPLE · NOT A REAL PATIENT · NOT MEDICAL ADVICE

PATIENT INFORMATION

معلومات المريض

NAME: [REDACTED] NATIONAL ID: [REDACTED]
AGE / SEX: 54 · Male COUNTRY: Egypt · مصر
FILES SUBMITTED: 6 · 14.2 MB REPORT LANGUAGE: عربي · English

THE PATIENT'S OWN QUESTION

سؤال المريض بكلامه

«دكتور قاللي لازم أعمل قسطرة. أنا بحس بضيق في صدري لما أمشي مسافة كبيرة، بس كل التحاليل اللي عملتها طلعت كويسة. عايز أعرف القسطرة دي ضرورية فعلاً، ولا في حاجة المفروض أعملها الأول؟»

"A doctor told me I need a catheterisation. I get chest tightness when I walk a long way, but every test I've had came back fine. I want to know whether the catheterisation is genuinely necessary, or whether there's something I should do first."

REVIEWING CONSULTANT

الاستشاري المراجع

CONSULTANT: Dr. [REDACTED] SYNDICATE REG. NO.: [REDACTED]
TITLE: Consultant Cardiologist AFFILIATION: Shifa · Tagammo



FINDINGS & OBSERVATIONS

النتائج والملاحظات

01 12-LEAD ECG • 14 SEP 2026

Sinus rhythm at 72 bpm. No ST-segment deviation and no pathological Q waves on the trace supplied.

رسم قلب بـ ١٢ طرف: نظم جيبي ٧٢ نبضة في الدقيقة. لا يوجد انحراف في القطعة ST ولا موجات Q مرضية في الرسم المرفق.

02 TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAM • 15 SEP 2026

Left ventricular ejection fraction 58%. Wall motion normal at rest. No significant valvular lesion reported.

إيكو على القلب: الكسر القذفي للبطين الأيسر ٥٨%. حركة جدار القلب طبيعية أثناء الراحة. لا يوجد خلل صمامي يُذكر.

03 HIGH-SENSITIVITY TROPONIN • TWO SAMPLES, 6 HOURS APART

Both values within the laboratory reference range, with no rise between samples.

تروبونين عالي الحساسية في عينتين بفارق ٦ ساعات: القيمتان ضمن المعدل الطبيعي للمعمل، بدون أي ارتفاع بين العينتين.

04 LIPID PANEL • 14 SEP 2026 **OUTSIDE TARGET**

LDL-cholesterol 168 mg/dL — above the target usually applied to this risk profile.

تحليل الدهون: الكوليسترول الضار ١٦٨ ملجم/ديسيلتر، أعلى من المستهدف المعتاد لهذه الفئة من الخطورة.

05 NOT PRESENT IN THE SUBMITTED FILE **GAP**

No functional test of ischaemia — exercise ECG, stress echocardiogram or myocardial perfusion imaging — appears anywhere in the material provided.

لا يوجد في الملف المرفوع أي اختبار وظيفي للإقفار — لا رسم قلب بالمجهود، ولا إيكو بالمجهود، ولا تصوير تروية عضلة القلب.



IMPRESSION & CONCLUSION

الانطباع والخلاصة

The material supplied documents exertional chest discomfort alongside a normal resting cardiac assessment and no biochemical evidence of myocardial injury. Critically, the file contains no functional or anatomical assessment of ischaemia. On the documents provided, an indication for invasive coronary angiography is **not established**. In a presentation of this kind the conventional next step is a non-invasive assessment of ischaemia, the result of which then determines whether catheterisation is warranted.

المستندات المرفوعة بتوصف ضيق في الصدر مع المجهود، مع فحص قلب طبيعي أثناء الراحة، وبدون أي دليل معلمي على إصابة عضلة القلب. والأهم إن الملف مفيهوش أي تقييم وظيفي أو تشريحي للإقفار. بناءً على المستندات المتاحة، **مفيش ما يثبت** ضرورة القسطرة التشخيصية في الوقت الحالي. الخطوة المعتادة في الحالة دي هي تقييم غير تداخلي للإقفار، ونتيجته هي اللي بتحدد إذا كانت القسطرة لازمة فعلاً.

RECOMMENDATIONS

التوصيات

- 1** **Raise a non-invasive ischaemia test with the treating cardiologist before agreeing to catheterisation** — an exercise ECG, stress echocardiogram or myocardial perfusion scan, whichever that doctor judges most suitable.
ناقش مع طبيبك المعالج اختبار إقفار غير تداخلي قبل الموافقة على القسطرة — رسم قلب بالمجهود أو إيكو بالمجهود أو تصوير تروية، حسب ما يراه مناسباً.
- 2** **Ask one specific question at that appointment:** "What result would change the plan?" A test that cannot change management is worth questioning.
اسأل سؤال واحد محدد في الكشف: «إيه النتيجة اللي ممكن تغيّر الخطة؟» أي فحص مش هيغيّر القرار يستاهل السؤال عنه.
- 3** **The LDL-cholesterol of 168 mg/dL needs attention in its own right**, independently of the catheterisation decision. Discuss it at the same visit.
الكوليسترول الضار ١٦٨ محتاج متابعة في حد ذاته، بغض النظر عن قرار القسطرة. ناقشه في نفس الزيارة.
- 4** **Go to an emergency department immediately** if chest pain occurs at rest, lasts more than 15 minutes, or comes with breathlessness, sweating or pain spreading to the arm or jaw. Do not wait for any appointment.
روح الطوارئ فوراً لو حصل ألم في الصدر وإنّت مرتاح، أو استمر أكثر من ١٥ دقيقة، أو جه معاه ضيق نفس أو عرق أو ألم بيتنشر للذراع أو الفك. متستناش أي معاد.
- 5** **Take this report with you.** It is written to be handed to the treating physician, not to replace them.
خد التقرير ده معاك. هو مكتوب عشان يتسلم للطبيب المعالج، مش عشان يحل محله.



نموذج توضيحي — مش تقرير حقيقي ومش بيانات مريض حقيقي

SAMPLE • NOT A REAL PATIENT • NOT MEDICAL ADVICE

ANNOTATED IMAGES

الصور المؤشحة

IMAGES REMOVED FOR THIS SAMPLE

In a real report this section carries the patient's own scans with the consultant's markings and a note on each.

في التقرير الحقيقي القسم ده بيحتوي على صور المريض نفسه وعليها علامات الاستشاري وتعليق على كل صورة.

CONSULTANT SIGNATURE

توقيع الاستشاري

[Signature]

CONSULTANT CARDIOLOGIST • SHIFA HOSPITAL GROUP
SIGNED 19 SEP 2026 • 14:02 EET

41h 48m

TURNAROUND ON A
STANDARD 48-HOUR CASE

DISCLAIMER

إخلاء المسؤولية

This is a written second opinion based solely on the documents supplied by the patient. It is not a diagnosis, does not follow a physical examination, and does not replace the treating physician or any prescription they have issued. No medication is prescribed or altered by this report. If the supplied documents are incomplete or superseded, the conclusions above may not apply.

ده رأي طبي ثاني مكتوب بناءً على المستندات اللي رفعها المريض بس. مش تشخيص، ومش مبني على كشف إكلينيكي، وميحلش محل الطبيب المعالج ولا الروشتة اللي كتبها. التقرير ده مبيوصفش ولا بيغير أي دواء. لو المستندات ناقصة أو اتغيرت، ممكن الخلاصة اللي فوق متنطبقش.